



**FACULTAD DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA**

PLAN DE TESIS

**PERCEPCIÓN DE LAS MADRES ACERCA DE LA ATENCIÓN DE
ENFERMERÍA A NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS EN EL SERVICIO DE
CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CENTRO DE SALUD "JESÚS MARÍA"**

**PARA OPTAR
TITULO DE LICENCIADA EN ENFERMERIA**

**PRESENTADO POR:
KATERIN ESTEFANI BAO VILLA**

**ASESORA
Mg. ROSA HIRMA BARRUETA CALDAS**

LIMA, PERÚ

2023

ÍNDICE

Págs.

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la situación problemática	3
1.2 Formulación del problema	7
1.3 Objetivos de la investigación	9
1.4 Justificación de la investigación	10
1.4.1 Importancia de la investigación	10
1.4.2 Viabilidad del estudio	10
1.5 Limitaciones de estudio	12

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación	14
2.2 Bases teóricas	18
2.3 Definición de términos básicos	24

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1 Formulación de hipótesis principal y derivadas	25
3.2 Variables y definición operacional	25

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA

4.1 Diseño metodológico	30
4.2 Diseño muestral	30
4.3 Técnica de recolección de datos	31
4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información	33
4.5 Aspectos éticos	35

CRONOGRAMA	38
-------------------	----

PRESUPUESTO	39
--------------------	----

FUENTES DE INFORMACIÓN	40
-------------------------------	----

ANEXOS	43
---------------	----

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la situación problemática

La investigación de percepción de las madres sobre la atención de enfermería a niños menores de 4 años en el servicio de crecimiento y desarrollo busca comprender las opiniones, experiencias y satisfacción de las madres acerca de los cuidados que brindan las enfermeras a sus hijos en el consultorio de crecimiento y desarrollo, donde la enfermera evalúa periódicamente al niño y detecta tempranamente cualquier alteración en el crecimiento físico, desarrollo neurológico, cognitivo, social y emocional de los niños.

Analizar la percepción no solo brinda información sobre la calidad de los cuidados, también contribuye a mejorar la práctica de enfermería y por ende en el bienestar de los niños en esta fase crucial de su desarrollo. La noción de percepción ha experimentado varias interpretaciones a lo largo del tiempo, evolucionando hacia la inclusión de las vivencias y los procedimientos internos del sujeto. Se trata de un proceso dinámico y constructivo, en el cual el observador, previo a procesar la información reciente y basándose en la información previamente almacenada en su mente, edifica un marco informativo anticipado. Este marco le posibilita comparar el estímulo y determinar su aceptación o rechazo, en función de su concordancia con lo previamente establecido.¹

La Organización Panamericana de la Salud (OPS)², señala que la evaluación de

la calidad de atención percibida conlleva la medición de la calidad de los servicios de salud, con el objetivo de elevar las posibilidades de lograr resultados favorables tanto para las personas como para las comunidades. Así mismo afirma que la percepción de la atención implica brindar servicios de salud caracterizados por un enfoque centrado en las personas, familias y comunidades. Esto se logra a través de la provisión de cuidados con niveles óptimos de seguridad, efectividad, puntualidad, eficiencia y un acceso equitativo, considerados como atributos esenciales.

El logro de estas cualidades está influenciado por la disponibilidad de servicios y la apropiada organización y gestión de estos. Elevar la calidad de la atención en la prestación de servicios de salud demanda una transformación y un fortalecimiento profundos en el mismo sistema en nuestro País ,que evidencia actualmente datos alarmantes respecto a desnutrición infantil ,anemia ferropénica, exposición a la violencia dentro y fuera de casa.

Ramona Mercer desarrollo la "Teoría de la Transición Materna". Esta teoría se centra en el proceso que experimentan las mujeres durante el período de transición a la maternidad, es decir, desde el momento en que se enteran de que están embarazadas hasta el primer año después del parto. La teoría se basa en la idea de que las madres atraviesan una serie de transiciones emocionales, físicas y sociales durante este período, y la enfermera desempeña un papel fundamental en apoyar a las madres durante este proceso. Esta teoría proporciona los fundamentos teóricos a ser utilizados en el cuidado del niño en el programa de CRED para entender y mejorar el apoyo a las madres durante la maternidad.³ Esta teoría tiene un impacto significativo en la práctica de enfermería al proporcionar marcos conceptuales sólidos para comprender y abordar las

necesidades de las madres en el desarrollo de la maternidad. ³⁻⁴

En el país se han realizado diversas investigaciones respecto a la percepción de madres sobre la calidad del cuidado enfermero como la de Monzón y su equipo en un centro de salud en Chiclayo en 2019, investigación de enfoque cuantitativo con una muestra de 122 madres, halló que el 50.8% de las madres tenía una percepción regular del cuidado enfermero, mientras que solo el 49.2% la consideraba buena. La dimensión técnico-científica del cuidado enfermero fue de 73% de las madres como percepción buena. En general, la percepción de la calidad del cuidado enfermero fue considerada regular, lo que no cumple con las expectativas de satisfacción del usuario. ⁵

El Ministerio de salud (MINSA) hace referencia que la baja calidad de la atención constituye actualmente uno de los mayores obstáculos para enfrentar con éxito los problemas sanitarios, el sistema de salud del país no ha logrado un adecuado desarrollo, no cuentan con suficientes recursos material y humano, reconoce signos de creciente preocupación por la calidad de la atención que se brinda en los servicios de salud, debido a que los resultados alcanzados no son del todo satisfactorios ni confiables. La situación es más difícil y compleja en las zonas de difícil acceso marcando la diferencia entre la vida y la muerte. ⁶

La atención de enfermería en el Servicio de Crecimiento y Desarrollo reviste una significativa importancia para el bienestar y desarrollo integral de los infantes en sus primeros años de vida. Durante este crucial período de crecimiento, la atención de enfermería no solo se fundamenta en aspectos técnicos y científicos, sino que

también implica interacciones humanas y un entorno adecuado que influyen en la percepción materna, por ende, en la calidad de la atención brindada.

Las dimensiones que abarcan esta atención son diversas y esenciales para una atención integral de calidad. En primer lugar, encontramos la dimensión técnico-científica, que se relaciona con la aplicación de conocimientos del cuidado destinados a asegurar la salud y el desarrollo óptimo del niño. Además, se encuentra la dimensión humana, que abarca elementos fundamentales como la empatía, la comunicación efectiva y el apoyo emocional brindado por el profesional de enfermería. Esta dimensión crea un entorno propicio para la construcción de la confianza y el bienestar emocional tanto del niño como de la madre, fomentando un enfoque holístico en la atención.

Esta también la dimensión del entorno que considera el contexto físico y social en el cual se desarrolla la atención. Aspectos como la infraestructura, la accesibilidad a los servicios, la disponibilidad de recursos y la percepción general del entorno por parte de las madres son elementos cruciales que influyen en la experiencia y resultados de la atención de enfermería.

Martínez en su trabajo de investigación realizado en el 2017 en el distrito de Barranco encontró que de un total de 150 consultas de CRED, el 15% de los niños menores de 4 años no recibieron atención en el servicio de crecimiento y desarrollo. Esta situación plantea graves problemas, ya que la falta de evaluación puede llevar a la detección tardía de posibles trastornos del crecimiento y desarrollo en los niños, lo que a su vez podría resultar en retrasos en su desarrollo

físico y cognitivo. Además, la ausencia de evaluación temprana también impide la detección precoz de condiciones clínicas subyacentes, lo que podría poner en riesgo la salud de los niños y limitar las oportunidades de intervención temprana para abordar cualquier problema identificado. En este sentido, surge la necesidad de explorar y comprender en profundidad la percepción materna sobre la atención de enfermería a niños menores de 4 años en el centro de salud de Jesús María, desde estas tres dimensiones interrelacionadas.⁷

En el contexto del Centro de Salud "Jesús María", la percepción de las madres sobre la atención de enfermería a sus hijos menores de 4 años se encuentra influenciada por una serie de desafíos. La calidad de la atención, la comunicación eficaz, las condiciones de las instalaciones, los recursos educativos, los desafíos socioeconómicos de las madres, la sobrecarga del personal de enfermería y la cultura organizacional en el centro de salud son factores cruciales que intervienen en la percepción de las madres de como experimentan la atención de la salud de sus pequeños. Identificar y comprender estos problemas se vuelve esencial para discernir la percepción de las madres, ya que solo al abordar estos desafíos de manera efectiva se podrá mejorar la calidad de la atención y, en última instancia, el bienestar de los niños.

1.2 Formulación del problema

¿Cuál es la percepción de las madres sobre la atención de enfermería brindada a niños menores de 4 años en el Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud 'Jesús María' durante el periodo de enero a marzo del 2024?

A partir de esta interrogante surgen preguntas específicas en torno a las dimensiones de la atención:

- ¿Cuál es la percepción materna acerca de la atención de enfermería en niños menores de 4 años en el centro de salud de Jesús María, considerando la dimensión técnico-científica?
- ¿Cuál es la percepción de las madres acerca de la atención de enfermería brindada a niños menores de 4 años en el centro de salud de Jesús María respecto a la dimensión humana?
- ¿Cuál es la percepción de las madres sobre la atención de enfermería en niños menores de 4 años en el centro de salud de Jesús María, respecto a la dimensión entorno?

1.3 Objetivos de la investigación

Objetivo principal

Identificar la percepción materna respecto a la atención de enfermería en niños menores de 4 años en el servicio de crecimiento y desarrollo del centro de salud Jesús María durante el periodo de enero a marzo del 2024.

Objetivos específicos

- Identificar la percepción materna acerca de la atención de enfermería en niños menores de 4 años en el centro de salud de Jesús María, enfocándose en la dimensión técnico-científica.
- Identificar la percepción de las madres en relación a la atención de enfermería brindada a niños menores de 4 años en el centro de salud de Jesús María,

centrándose en la dimensión humana.

- Identificar la percepción de las madres sobre la atención de enfermería en niños menores de 4 años en el centro de salud de Jesús María, especialmente en lo que respecta a la dimensión entorno.

1.4 Justificación de la investigación

1.4.1 Importancia de la investigación

La importancia de esta investigación radica en su contribución al análisis exhaustivo de la percepción materna en relación con la atención de enfermería brindada a niños menores de 4 años en el servicio de crecimiento y desarrollo del centro de salud Jesús María, durante el periodo de enero a marzo del 2024.

Esta investigación ofrece valiosa información que puede influir en la toma de decisiones y la mejora de los servicios de atención de enfermería, al identificar áreas de fortaleza y posibles deficiencias en diferentes aspectos de la atención. Los resultados obtenidos permitirán a los profesionales de la salud y a las autoridades del centro de salud Jesús María ajustar y optimizar sus prácticas, recursos y enfoques en función de las necesidades y expectativas de las madres, con el objetivo de ofrecer una atención más efectiva, centrada y satisfactoria para los niños menores de 4 años y sus familias. En última instancia, esta investigación también contribuirá al avance de la calidad asistencial y al bienestar de la población infantil atendida en este centro de salud.

1.4.2 Viabilidad del estudio

La viabilidad de este estudio está respaldada por varios factores clave. En primer lugar, el objetivo se enfoca en evaluar la percepción materna sobre la atención de enfermería en un grupo específico: niños menores de 4 años en el servicio de crecimiento y desarrollo del centro de salud Jesús María. Esto proporciona un enfoque preciso y delimitado, lo que facilita la recolección de datos y el análisis detallado.

Además, el período de tiempo establecido para la investigación asegura una ventana adecuada para la recopilación de información y análisis, permitiendo obtener resultados representativos y actuales.

La viabilidad también se respalda por la disponibilidad de recursos necesarios, como el acceso al centro de salud y la colaboración con madres dispuestas a participar en el estudio. La infraestructura y el personal del centro de salud ofrecen un entorno propicio para llevar a cabo la investigación de manera efectiva.

La aplicación de metodologías de investigación adecuadas, como encuestas y entrevistas estructuradas, permitirá recopilar datos cuantitativos y cualitativos de manera sistemática y rigurosa.

Estos elementos aseguran que el estudio pueda llevarse a cabo de manera efectiva y proporcionar información valiosa sobre la percepción materna en

relación a la atención de enfermería en niños menores de 4 años en el centro de salud Jesús María.

1.5 Limitaciones de estudio

A pesar de la viabilidad y el enfoque cuidadosamente planificado de este estudio, es importante reconocer y abordar posibles limitaciones que podrían influir en la interpretación de los resultados. Algunas de las limitaciones potenciales podrían incluir:

Tamaño de la muestra: Debido a la naturaleza específica de la población objetivo y al período de tiempo definido, el tamaño de la muestra podría ser limitado. Esto podría afectar la representatividad de los resultados y su generalización a otras poblaciones o momentos temporales.

Participación voluntaria: La recolección de datos se basará en la participación voluntaria de las madres. Las madres que optan por participar podrían tener opiniones diferentes de aquellas que deciden no participar.

Percepción subjetiva: La evaluación de la percepción materna se basa en la subjetividad y las experiencias individuales. Esto podría influir en la variabilidad de las respuestas y dificultar la obtención de una imagen completa y precisa de la percepción general.

Período de tiempo limitado: El estudio se llevará a cabo en un período

específico de tres meses (de enero a marzo del 2024), lo que podría no capturar todas las variaciones estacionales u otros factores temporales que podrían influir en la percepción materna.

Contexto cultural y local: Dado que el estudio se realizará en un centro de salud específico y en un contexto cultural y local determinado, los resultados podrían no ser completamente aplicables a otras ubicaciones geográficas o culturas diferentes.

Medición de la variable: La medición de la percepción materna y otros factores podría depender de instrumentos de medición que podrían tener limitaciones en términos de validez y confiabilidad.

Estas limitaciones deben ser consideradas al interpretar los resultados del estudio y al hacer recomendaciones basadas en ellos. Abordar estas limitaciones de manera transparente y tomarlas en cuenta en el análisis contribuirá a una interpretación más precisa y equilibrada de los hallazgos.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

Internacionales

El estudio realizado por Flores, Ortiz Félix y Cárdenas en México en 2012 se centró en analizar el cuidado de enfermería proporcionado a niños sanos en un hospital de seguridad social. Utilizaron observación directa en 87 interacciones de cuidado de niños sanos en una Unidad de Medicina Familiar, así como entrevistas semiestructuradas con 25 madres que llevaron a sus hijos a la consulta de cuidado del niño sano. Los resultados revelaron que las acciones del personal se centraron principalmente en procedimientos como medir peso y talla, supervisar la alimentación e inmunizaciones, lo que sugiere que la atención no se enfocó en un cuidado integral del niño sano. Los autores sugieren la necesidad de mejorar la educación en enfermería y fortalecer la relación de confianza para brindar una atención más integral.⁸

En un estudio en Antioquia por la Gobernación de esa región colombiana, se evidencia una alta inasistencia al programa CRED según una encuesta nacional de salud. Solo el 30.6% de los padres llevó a sus hijos a un control de crecimiento y desarrollo, disminuyendo proporcionalmente con controles adicionales. Esta situación se relaciona con factores institucionales, incluida la calidad de atención por parte del personal de enfermería. Este hallazgo plantea un contexto relevante para la presente investigación sobre la percepción

materna en la atención de enfermería en el mismo programa.⁹

Nacionales

En 2019, Monzon y Tunjar examinaron la percepción de madres sobre la calidad del cuidado enfermero en el consultorio de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud MINSA en Chiclayo. La investigación de enfoque cuantitativo y descriptivo involucró a 360 madres, con una muestra de 122 seleccionadas por muestreo no probabilístico. Utilizando un cuestionario validado, se observó que el 50,8% tenía percepción regular, mientras que el 49,2% tenía percepción favorable. Las dimensiones del cuidado enfermero también se evaluaron, destacando que el 73% consideraba buena la dimensión Técnico-Científica y el 70,5% tenía percepción positiva en la dimensión Interpersonal. En la dimensión del entorno, el 50,8% tenía percepción positiva. En resumen, la mayoría de madres percibió la calidad del cuidado enfermero como regular, especialmente en la dimensión técnico-científica.⁵

Martínez desarrolló un estudio que tuvo como objetivo evaluar la percepción de las madres de niños menores de 5 años sobre la atención de enfermería en el programa de crecimiento y desarrollo en la Institución Prestadora de Servicios de Salud "Barranco" durante el período de marzo a mayo de 2017. Esta investigación se enmarcó en un enfoque cuantitativo, observacional, descriptivo, prospectivo y de corte transversal. La población de estudio estuvo compuesta por 284 madres que tenían niños menores de 5 años. Para recopilar los datos, se utilizó una encuesta como técnica principal, con instrumentos que

incluían una ficha de recolección y una escala de percepción sobre la atención de enfermería en el programa de crecimiento y desarrollo. Los resultados revelaron que la mayoría de las madres tenían una percepción favorable de la atención de enfermería en el programa CRED, con un 85.2% reportando una percepción positiva, mientras que un 9.5% expresó una percepción desfavorable. Estas percepciones se dividieron en las dimensiones interpersonal, técnico-científica y del entorno, y en todas ellas predominaron las evaluaciones favorables. En conclusión, el estudio de Martínez mostró que la mayoría de las madres evaluaron positivamente la atención de enfermería en el programa de crecimiento y desarrollo para sus hijos menores de 5 años. ⁷

Lampa y Vega llevaron a cabo un estudio con el objetivo de determinar la percepción de los padres que tienen hijos menores de cinco años sobre el cuidado humanizado proporcionado por profesionales de enfermería en los servicios de Crecimiento y Desarrollo de la Unidad Básica de Gestión en Ate. La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, tipo descriptivo y corte transversal. La muestra fue probabilística y consistió en 350 participantes. Se empleó un instrumento de recolección de datos validado y creado por Maritza Guinea (2016), con una confiabilidad de 0.88 de Alfa de Cronbach. ¹⁰

Los resultados indicaron que, del total de encuestados, el 50.6% presentó una percepción medianamente favorable, seguido de un 48.9% de padres que expresaron una percepción favorable, y solo un 0.5% manifestó una percepción desfavorable. En cuanto a la dimensión interpersonal, el 51.7% de los padres

tenía una percepción medianamente favorable. En la dimensión técnico-científica, el 81.4% tenía una percepción medianamente favorable. Finalmente, en la dimensión del entorno, el 52% tenía una percepción favorable. En resumen, se concluyó que la percepción de los padres con hijos menores de cinco años sobre el cuidado humanizado proporcionado por profesionales de enfermería en los servicios de Crecimiento y Desarrollo es en su mayoría medianamente favorable. ¹⁰

En 2016, en Lima, Guinea M. llevó a cabo un estudio titulado "Percepción de padres de niños menores de 5 años sobre atención humanizada de enfermera en servicio CRED en centro de salud Mirones". El objetivo fue determinar la percepción de los padres sobre la atención humanizada de enfermería. Utilizando una metodología cualitativa y descriptiva, la población incluyó a 30 padres. Los resultados revelaron que el 53% tenía una percepción medianamente favorable, el 27% favorable y el 20% desfavorable. En las dimensiones interpersonales, técnica y del entorno, también se observaron distintos niveles de percepción. Se concluyó que la mayoría de los padres tenían una percepción medianamente favorable, destacando la amabilidad y el respeto en el trato de enfermería. ¹¹

2.2 Bases teóricas

Control de crecimiento y desarrollo de los niños menores de 5 años

El desarrollo integral de la infancia es esencial para el progreso humano y la construcción de capital social, siendo cruciales para romper el ciclo de pobreza y reducir las desigualdades. ¹²

El crecimiento se refleja en el aumento del peso y la estatura, mientras que el desarrollo abarca cambios en aspectos físicos, neurológicos, cognitivos y conductuales. Investigaciones recientes subrayan la importancia de la primera infancia en la formación de la inteligencia, personalidad y comportamiento social.

La falta de atención y cuidado en esta etapa puede tener consecuencias acumulativas y duraderas. Por tanto, proporcionar oportunidades adecuadas de crecimiento y desarrollo es una prioridad para familias, gobiernos, organizaciones y comunidades. No se conoce el número exacto de niños peruanos con retraso en el desarrollo debido a la salud, nutrición y condiciones adversas durante la gestación y los primeros años de vida en entornos excluyentes.¹²

Según la encuesta ENDES 2010, el 17.9% de los menores de cinco años tiene desnutrición crónica y el 50.3% de los niños de 6 a 36 meses padece anemia nutricional. Estos indicadores sugieren que muchos niños podrían enfrentar problemas en su desarrollo, ya que el retraso en el crecimiento y la anemia son señales de entornos poco favorables para el crecimiento y desarrollo. Es esencial monitorear el crecimiento y desarrollo de los niños para detectar riesgos y trastornos a tiempo, brindando atención adecuada y promoviendo prácticas de cuidado y crianza apropiadas en el ámbito de la familia y la comunicad.¹³

La Norma Técnica de Salud para el Control del Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño menor de cinco años ¹³, establece varios objetivos para la estrategia CRED (Crecimiento y Desarrollo). Los principales objetivos de esta estrategia son:

- Promover el control regular del crecimiento y desarrollo de los niños menores de cinco años: El objetivo central de la estrategia CRED es asegurar que todos los niños menores de cinco años sean sometidos a un control periódico de su crecimiento y desarrollo para detectar tempranamente posibles problemas de salud o desarrollo.
- Detectar oportunamente alteraciones en el crecimiento y desarrollo: La estrategia busca identificar de manera temprana cualquier alteración en el crecimiento físico, desarrollo neurológico, cognitivo, social y emocional de los niños, con el fin de tomar medidas preventivas o terapéuticas oportunas.
- Facilitar la atención integral de los niños: CRED tiene como objetivo contribuir a la atención integral de los niños, abordando no solo aspectos físicos sino también emocionales y sociales, para asegurar su bienestar general.
- Promover prácticas adecuadas de cuidado y crianza: La estrategia busca proporcionar orientación a los padres y cuidadores sobre prácticas adecuadas de cuidado y crianza que fomenten un desarrollo saludable en los niños.
- Reducir las brechas de inequidad en salud: CRED se orienta a reducir las desigualdades en el acceso a la atención de salud y garantizar que

todos los niños, independientemente de su ubicación geográfica o situación económica, reciban el control del crecimiento y desarrollo.

- Mejorar la calidad de la atención en salud infantil: La estrategia busca elevar los estándares de calidad en la atención de salud infantil, asegurando que se sigan pautas basadas en evidencia científica y se promueva un enfoque integral en el cuidado de los niños menores de cinco años.

La estrategia CRED tiene como objetivos fundamentales la detección temprana de problemas de crecimiento y desarrollo en niños menores de cinco años, la promoción de prácticas adecuadas de cuidado y crianza, y la mejora general de la calidad de atención en salud infantil.

Adherencia de los padres a esta estrategia

La adherencia de los padres o cuidadores al programa de control del crecimiento y desarrollo de niños reviste una importancia crítica en la salud infantil. La percepción que estos adultos tienen respecto a la atención en esta intervención sanitaria desempeña un papel fundamental, ya que influye directamente en la continuidad de la participación en el programa. ⁴

Cuando éstos comprenden la relevancia de esta atención y tienen una percepción positiva de ella, están más inclinados a seguir las recomendaciones, acudir a las citas y comprometerse en las actividades de seguimiento. Esto, a su vez, contribuye a una detección temprana de posibles problemas de salud o

desarrollo en los niños, permitiendo intervenciones oportunas que pueden prevenir complicaciones a largo plazo. ^{4,7}

En última instancia, la adherencia de los padres y su percepción favorable no solo benefician a los niños en su crecimiento y desarrollo, sino que también promueven una atención sanitaria más efectiva y una mejora en los resultados de salud infantil en la comunidad en general. ⁷

Atención del personal de enfermería

Se puede analizar y evaluar desde diversas dimensiones clave que abordan diferentes aspectos de la atención brindada. En el contexto del Control de crecimiento y desarrollo de niños, estas dimensiones incluyen ¹²

Dimensión Técnico-Científica

Esto implica considerar la calidad de las prácticas de enfermería, la aplicación de procedimientos médicos basados en evidencia científica, la precisión en la administración de tratamientos y medicamentos, y la eficacia de las intervenciones desde un enfoque clínico.¹⁴

Dimensión Humana

En esta dimensión, se analiza la percepción materna sobre la atención de enfermería desde una perspectiva humanística. Esto involucra aspectos como la empatía, la comunicación efectiva, la comprensión de las necesidades emocionales de los niños y las madres, y la calidad de la interacción entre el

personal de enfermería y las familias, con un enfoque en el aspecto humano y emocional de la atención. ¹⁴

Dimensión de Entorno

Esto abarca aspectos como la comodidad de las instalaciones del centro de salud, la disponibilidad de recursos necesarios, la accesibilidad geográfica, la organización de los servicios de salud y cualquier otro factor relacionado con el ambiente en el que se lleva a cabo la atención. ¹⁴

Percepción

La percepción es el proceso cognitivo mediante el cual los individuos captan, organizan e interpretan la información sensorial que reciben a través de sus sentidos, como la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Este proceso les permite tomar conciencia y comprender el entorno que les rodea, identificar objetos, reconocer estímulos y atribuir significado a lo que experimentan, lo que a su vez influye en su comprensión y respuesta a su entorno. La percepción está influida por factores individuales y contextuales, y puede variar de una persona a otra, lo que la convierte en un proceso subjetivo y complejo.¹⁴

Percepción de la atención de enfermería en la estrategia sanitaria CRED

La teoría de Mercer sobre la transición materna podría ser relevante en el contexto de la percepción de atención en CRED, especialmente en lo que respecta a las mujeres embarazadas y las madres que forman parte de esta estrategia sanitaria.

En el contexto de la estrategia sanitaria CRED, la teoría de Mercer puede ser aplicada de la siguiente manera:

- **Apoyo durante la transición a la maternidad:** La estrategia sanitaria CRED probablemente involucra el cuidado y la atención a mujeres embarazadas y madres. La teoría de Mercer destaca la importancia de brindar apoyo durante esta transición crucial en la vida de una mujer, lo cual podría ser aplicable para mejorar la percepción de atención en CRED.
- **Consideración de las necesidades emocionales y sociales:** La teoría de Mercer reconoce que las madres pasan por transiciones emocionales y sociales. La estrategia CRED podría beneficiarse al considerar estas dimensiones en su atención, lo que podría contribuir a una percepción más positiva de la atención recibida.
- **Marco conceptual sólido:** La teoría de Mercer proporciona un marco conceptual sólido para entender las necesidades de las madres durante la maternidad. Al aplicar este marco en la estrategia CRED, los profesionales de la salud podrían mejorar la calidad de la atención y, en última instancia, influir en una percepción más favorable por parte de las pacientes.

Nola Pender es una influyente enfermera y teórica de enfermería conocida por desarrollar la "Teoría de la Promoción de la Salud". Esta teoría se centra en el empoderamiento de las personas para tomar decisiones saludables y promover su bienestar. ⁴

En el contexto de la estrategia sanitaria CRED, la teoría de Pender puede ser aplicada de la siguiente manera:

- **Empoderamiento de las mujeres embarazadas y madres:** La estrategia sanitaria CRED podría beneficiarse al empoderar a las mujeres embarazadas y madres, permitiéndoles tomar decisiones informadas sobre su salud y la de sus hijos. La teoría de Pender enfatiza la importancia de brindar a las personas el conocimiento y las habilidades necesarias para cuidar de sí mismas y de sus familias.
- **Fomento de la motivación y la autoeficacia:** La teoría de Pender resalta la importancia de la motivación y la autoeficacia en la adopción de comportamientos saludables. En el contexto de la estrategia CRED, se podría promover la motivación y la confianza de las mujeres para buscar y recibir atención de manera oportuna y efectiva.
- **Consideración de factores personales y ambientales:** La teoría de Pender también reconoce que los comportamientos de salud están influenciados por factores personales y ambientales. Esto significa que la estrategia CRED debe tener en cuenta las circunstancias individuales de las mujeres y las condiciones en las que viven para proporcionar una atención que se adapte a sus necesidades específicas.

Hildegard Peplau fue una destacada enfermera y teórica de enfermería conocida por desarrollar la "Teoría de las Relaciones Interpersonales en Enfermería". Esta teoría se centra en la importancia de la relación entre el enfermero y el paciente en el proceso de atención médica.¹⁵

En el contexto de la estrategia sanitaria CRED, la teoría de Peplau puede ser aplicada de la siguiente manera:

- **Enfoque en la relación de enfermería-paciente:** La estrategia sanitaria CRED puede beneficiarse al enfocarse en el desarrollo de relaciones efectivas entre el personal de enfermería y las mujeres embarazadas o madres. La teoría de Peplau enfatiza que la calidad de la relación puede influir en la percepción del paciente sobre la atención recibida.
- **Comunicación y empatía:** La teoría de Peplau resalta la importancia de la comunicación efectiva y la empatía en la relación enfermero-paciente. En el contexto de CRED, los profesionales de la salud pueden mejorar la percepción de atención al asegurarse de que la comunicación sea clara y que se demuestre empatía hacia las necesidades y preocupaciones de las mujeres atendidas.
- **Apoyo emocional:** Peplau también hizo hincapié en el papel del enfermero en el apoyo emocional del paciente. En el contexto de la maternidad y la estrategia CRED, brindar apoyo emocional a las mujeres embarazadas y madres puede contribuir en gran medida a una percepción positiva de la atención recibida.

En la etapa de cuidar y ser cuidado, la percepción es un proceso individual y subjetivo que se construye en función de la identificación de los problemas de salud y las necesidades del niño y sus familias que requieren cuidados. Esta construcción se basa en la relación y la percepción mutua entre quienes brindan el cuidado y

quienes lo reciben, y puede llevar a la autonomía o a la dependencia según las actitudes del cuidador. ¹⁴

En el ámbito de la salud, la calidad se define tanto desde una perspectiva técnico-científica para los profesionales como desde la satisfacción del usuario. Esto implica considerar aspectos técnicos, científicos, metodológicos, así como las relaciones y percepciones en la atención de salud. La Organización Mundial de la Salud reconoce el derecho de todas las personas a la atención de salud de alta calidad y establece requisitos para ello, incluyendo excelencia profesional, uso eficiente de recursos, minimización de riesgos, alta satisfacción del usuario y un impacto positivo en la salud de la población. ^{4, 14}

Asegurar la calidad requiere que los profesionales de la salud reflexionen constantemente sobre sus valores, conocimientos, actitudes, habilidades y normas que guían la búsqueda del bienestar del paciente. Esta reflexión promueve acciones que buscan la mejora continua y orienta la práctica profesional hacia estrategias que priorizan la prestación de cuidados de alta calidad, abarcando las dimensiones técnico-científica, humana y de entorno. ¹³

2.3 Definición de términos básicos

Crecimiento

Se refiere al aumento medible y cuantificable en la estatura, peso y dimensiones físicas de los niños, que se evalúa mediante parámetros estándar de desarrollo

infantil y registros de salud.¹²

Desarrollo

Hace referencia al progreso en las habilidades cognitivas, motoras, sociales y emocionales de los niños, que se evalúa a través de indicadores de hitos del desarrollo, tales como el logro de habilidades motoras gruesas y finas, el lenguaje y la interacción social.¹²

Control de Crecimiento y Desarrollo

Conjunto de actividades regulares y planificadas llevadas a cabo por profesionales de enfermería o médicos, con el propósito de supervisar el crecimiento y desarrollo de los niños de manera efectiva y puntual. Estas actividades tienen como objetivo identificar tempranamente riesgos, irregularidades, o problemas, así como la detección de enfermedades, lo que facilita el diagnóstico y tratamiento oportuno para reducir posibles deficiencias y discapacidades. ¹²

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1 Formulación de hipótesis principal y derivadas

Dado que este estudio es un trabajo descriptivo con una variable no se formula hipótesis.

3.2 Variable y definición operacional

Variable Percepción Materna sobre la Atención de Enfermería

Proceso subjetivo de las madres de como captan, organizan e interpretan la atención que le brindan las enfermeras a sus niños en el programa CRED respecto a las dimensiones técnico-científica, humana y de entorno .

Dimensiones:

- **Dimensión Técnico-Científica:**

Percepción de las madres sobre la competencia técnica del personal de enfermería, la precisión en los procedimientos para evaluar crecimiento y desarrollo .

- **Dimensión Humana:**

Percepción de las madres sobre la empatía del personal de enfermería, la calidad de la comunicación, la consideración de las necesidades emocionales y la calidad de la interacción entre el personal de enfermería y

las familias.

- **Dimensión de Entorno:**

Percepción de las madres sobre las condiciones físicas y el ambiente del centro de salud, incluyendo la comodidad de las instalaciones, la disponibilidad de recursos y la accesibilidad geográfica.

TABLA 1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Dimensiones	Indicadores	Medición
Percepción Materna sobre la Atención de Enfermería	Dimensión Humana	Cortesía Respeto Interés Privacidad Confianza Seguridad Orientación Clara	1. Muy Favorable 2. Favorable 3. Ni favorable ni desfavorable 4. Desfavorable 5. Totalmente desfavorable
	Dimensión Técnico -Científica	Explica los procedimientos a realizar Realiza procedimientos de evaluación de crecimiento y desarrollo Identifica oportunamente alteración Explica a la madre lo hallado en la evaluación Informa sobre el cuidado	
	Dimensión del Entorno	Sala de espera confortable Consultorio confortable Consultorio limpio Consultorio ordenado Consultorio ventilado Consultorio iluminado Consultorio adaptado para el tipo de consulta Tiempo de espera	

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA

4.1 Diseño metodológico

Descriptivo, ya que la investigación tendrá como objetivo principal describir la percepción de las madres sobre la atención de enfermería en un período específico sin intervenir ni alterar el entorno. Se busca comprender la situación tal como es.

Respecto a la Temporalidad es una investigación Transversal, la encuesta se aplicará en un solo momento de tiempo, sin seguimiento a lo largo del tiempo. Se recopilarán datos en un tiempo determinado

4.2 Diseño muestral

Población de Estudio: La población de estudio estará compuesta por las madres de niños menores de 4 años que lleven a sus niños al Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud "Jesús María"

Tamaño de la Muestra: Para calcular el tamaño de la muestra, se consideró el promedio mensual de atenciones en el Servicio de Crecimiento y Desarrollo, que es de 105 atenciones a niños menores de 4 años. Dado que el estudio abarca tres meses, se estimó un total de 315 atenciones durante el período de estudio.

Cálculo del Tamaño de Muestra: Para garantizar un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, se utilizó la fórmula de cálculo de tamaño de muestra para poblaciones finitas. El tamaño mínimo de la muestra se determinó como un 30% del total de atenciones estimadas, lo que resulta en una muestra mínima de 95 madres.

Selección de la Muestra: La selección de la muestra se realizará de manera aleatoria y sistemática. Se obtendrá una lista de todas las madres que llevaron a sus niños al servicio durante el período de estudio, y luego se seleccionarán al azar 95 madres de esta lista para participar en la encuesta.

Criterios de Inclusión: Las madres que se incluirán en la muestra deben haber llevado a sus niños menores de 4 años al Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud "Jesús María".

Criterios de Exclusión: Se excluyen aquellas madres que no cumplan con los criterios de inclusión mencionados anteriormente o que se nieguen a participaren la encuesta. El proceso de selección y los criterios de inclusión y exclusión se llevarán a cabo de manera ética y respetando la privacidad y confidencialidad de las participantes.

4.3 Técnica de recolección de datos

Instrumento: Tomado del trabajo del trabajo de Martinez Vega “Percepción Sobre la Atención de Enfermería en el Programa de Crecimiento y Desarrollo en las Madres

de Niños Menores de 5 años. IPRESS Barranco, Marzo - Mayo, 2017”⁷

Para obtener la información necesaria, se utilizará una encuesta estructurada diseñada específicamente para esta investigación. El cuestionario de la encuesta incluirá preguntas relacionadas con las dimensiones de la percepción de las madres sobre la atención de enfermería brindada a sus niños menores de 4 años en el Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud "Jesús María".

Procedimiento de Aplicación: La encuesta se aplicará de manera personal a las madres seleccionadas en la muestra. Se asignará un momento conveniente para la entrevista, asegurando un entorno cómodo y privado que promueva la sinceridad y la apertura en las respuestas. Durante la aplicación de la encuesta, se proporcionará a las madres la oportunidad de hacer preguntas o aclaraciones si es necesario.

Validez: La validez del instrumento utilizado en este estudio ha sido previamente establecida en un contexto similar, específicamente en el estudio de Martínez Vega en 2017⁸. Esta validación previa garantiza que las preguntas sean pertinentes y apropiadas para medir la percepción de las madres sobre la atención de enfermería en el servicio de Crecimiento y Desarrollo. Además, para asegurar su idoneidad para los objetivos específicos de este estudio, se realizó una validación por juicio de expertos, en la cual cinco expertos en el tema de investigación evaluaron y concordaron en aceptar el instrumento, basándose en los indicadores utilizados en los antecedentes del presente estudio, (ANEXO A).⁷

Confiabilidad: cuanta de confiabilidad tiene el instrumento Se basa en la consistencia y estabilidad de las respuestas a lo largo del tiempo y entre diferentes encuestados. Dado que el instrumento ya ha sido validado en el contexto peruano en el estudio previo de Martinez Vega en 2017, se presume una buena confiabilidad en la medición de las variables de interés (ANEXO B).

Para asegurar la confiabilidad en la aplicación del instrumento, la investigadora incluirá instrucciones claras sobre cómo abordar a las participantes, formular preguntas y registrar las respuestas de manera consistente. Se realizará un seguimiento de los procedimientos de aplicación.

Además, es importante destacar que en el estudio de Martinez Vega en 2017, se llevó a cabo una prueba piloto con 30 madres de niños menores de 5 años, donde se obtuvo un valor de alfa de Cronbach de 0.89, lo que indica una fuerte confiabilidad en el instrumento utilizado para medir las variables de interés en esta investigación. Esto refuerza la confiabilidad del instrumento en el contexto de este estudio.⁷

4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información

Dado que esta investigación se centra en una metodología descriptiva, el procesamiento de la información se enfocará en la descripción detallada de la variable involucrada y sus dimensiones. A continuación, se explica qué se obtendría de cada variable:

Variable: Percepción Materna sobre Atención de Enfermería:

Dimensión Técnico-Científica: Se obtendrán estadísticas descriptivas que resuman la percepción de las madres sobre la competencia técnica del personal de enfermería, el conocimiento basado en evidencia científica. Esto incluirá promedios y desviaciones estándar para cada uno de estos aspectos técnicos.

Dimensión Humana: Se describirá la percepción de las madres sobre la empatía del personal de enfermería, la calidad de la comunicación, la consideración de las necesidades emocionales y la calidad de la interacción entre el personal de enfermería y las familias. Esto se presentará en términos de promedios y desviaciones estándar para cada elemento relacionado con la dimensión humana.

Dimensión de Entorno: Se proporcionará información sobre la percepción de las madres en relación con las condiciones físicas y el ambiente del centro de salud, incluyendo la comodidad de las instalaciones, la disponibilidad de recursos y la accesibilidad geográfica. Esto se expresará mediante estadísticas descriptivas de cada aspecto del entorno.

Variable: Percepción Materna General sobre la Atención de Enfermería

Esta variable representará una percepción general agregada de las dimensiones técnico-científica, humana y de entorno de la atención de enfermería en el centro de salud. Se calculará como una puntuación global de las tres dimensiones de la percepción. Esto proporcionará una medida sintetizada de la percepción materna

general sobre la atención de enfermería en el centro de salud durante el período de estudio.

En resumen, el procesamiento de la información se centrará en resumir y describir las percepciones maternas en las dimensiones técnico-científica, humana y de entorno, así como en calcular una puntuación global que refleje la percepción general sobre la atención de enfermería. Estos análisis descriptivos permitirán una comprensión detallada de la percepción de las madres en el contexto de estudio.

4.5 Aspectos éticos

Esta investigación se llevará a cabo con un enfoque ético sólido y se ajustará a los principios bioéticos fundamentales que guían la investigación en el campo de la salud. A continuación, se detallan las consideraciones éticas específicas que regirán el desarrollo de este estudio:

1. Principios Bioéticos:

- **Respeto por la Dignidad Humana:** Se asegurará el respeto absoluto por la dignidad y los derechos de las madres que participen en el estudio. Se protegerá su autonomía y se salvaguardará su privacidad en todo momento.
- **Beneficencia:** La investigación se llevará a cabo con el propósito de contribuir al conocimiento en el campo de la atención de enfermería infantil, buscando el beneficio de la comunidad al mejorar la calidad de la atención en el Servicio de Crecimiento y Desarrollo.
- **No Maleficencia:** Se tomarán medidas para prevenir cualquier daño

físico, psicológico o emocional a las madres participantes. La investigación no debe causar ningún perjuicio a las participantes.

- Justicia: Se garantizará la equidad en la selección de la muestra y se evitará cualquier forma de discriminación. Todos los datos se tratarán de manera imparcial y confidencial.

2. Consentimiento Informado:

Antes de participar en la investigación, todas las madres seleccionadas para la muestra recibirán una explicación completa y comprensible de los objetivos, procedimientos, beneficios y riesgos potenciales del estudio. Se les proporcionará un formulario de consentimiento informado que deberán leer y firmar voluntariamente si desean participar.

3. Confidencialidad:

Se garantizará que todos los datos recopilados sean tratados de manera confidencial. Se utilizarán códigos o identificadores en lugar de nombres reales para proteger la privacidad de las madres. Solo el equipo de investigación tendrá acceso a la información y se garantizará que los resultados no permitan la identificación individual.

4. Aprobación Ética:

Se contará con un asesor asignado por la universidad, quien deberá revisar y dar su conformidad ética con el protocolo de investigación.

Además, el protocolo de investigación será presentado a la Dirección Regional de

Salud (DIRIS) a la que pertenece el Centro de Salud "Jesús María" para su revisión y aprobación antes de la aplicación del estudio.

Estas consideraciones éticas se aplicarán de manera rigurosa en cada etapa del proceso de investigación. El respeto por la dignidad y los derechos de los participantes, así como la integridad y la calidad del estudio, son fundamentales para garantizar la ética y la validez de esta investigación.

CRONOGRAMA

TABLA 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

N°	Actividades	Meses			
		Julio a Agosto 2023	Setiembre Octubr e 2023	Noviem a Enero 2023	Febrer aMarzo 2024
1	Identificación y formulación del problema				
2	Revisión de las fuentes de información				
3	Redacción de objetivos y operacionalización de las variables				
4	Determinación del diseño de investigación				
5	Determinación del marco muestral				
6	Selección de los estadígrafos a utilizar				
7	Recolección de datos				
8	Organización y procesamiento de los datos				
9	Análisis e interpretación de los resultados				
10	Redacción del informe				
11	Presentación del informe				

PRESUPUESTO

TABLA 3. PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN

Tipo	Servicios	Unidad	Costo unidad	Monto total
Recursos humanos	Investigador	100 horas	60	6 000.00
	Personal para la tabulación	6 horas	50	300.00
	Análisis estadístico	6 horas	80	480.00
	Sub total			6 780.00
Adquisición de bienes	Material de escritorio (hojas, tóner de impresión, lapicero)			200.00
	Sub total			200.00
Servicios	Internet			180.00
	Impresión de cuestionarios y fotocopia de documentos			120.00
	Movilidad			200.00
	Sub total			500.00
Total general				7 480.00

FUENTES DE INFORMACIÓN

1. Malander NM. Percepción de prácticas parentales y estrategias de aprendizaje en estudiantes secundarios. Rev Psicol. 2016;25(1):1-19. [En línea] Disponible en: <http://dx.doi.org/10.5354/0719-0581.2016.42098>
2. Organización Panamericana de la Salud. Compilación de Legislación sobre Sistemas de Servicios de Emergencia en América Latina. Washington D.C. 2010. [En línea] Disponible en: http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/HSS-LEGEMC_2010S
3. Mercer RT. Experiencing maternal role attainment. West J Nurs Res. 1986;8(4):361-382. [En línea] Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3847870/>
4. Pender NJ, Murdaugh CL, Parsons MA. Health Promotion in Nursing Practice. Pearson; 2015.
5. Monzon Cotrina NO, Tunjar Oliva SS. Percepción de madres sobre calidad del cuidado enfermero en Consultorio de Crecimiento y Desarrollo del Niño, Centro de Salud MINSA. Chiclayo 2019 [tesis]. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; 2021. [En línea] Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12893/9582>
6. Ministerio de Salud (MINSA). Análisis de situación de Salud Perú. Lima; 2019. [En línea] Disponible en: https://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis/Asis_peru19.pdf
7. Martínez Vega MA. Percepción Sobre la Atención de Enfermería en el Programa de Crecimiento y Desarrollo en las Madres de Niños Menores de 5 años. IPRESS “Barranco”, Marzo - Mayo, 2017 [Tesis de licenciatura]. Lima:

- Universidad Peruana Los Andes, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Enfermería; 2018. [En línea] Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12848/477>
8. Flores Y, Ortiz R, Cárdenas V. Percepciones maternas del Cuidado del Niño Sano. Rev Latino-Am Enfermagem. 2012;20(2):1-7. [En línea] Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692012000200009>
 9. Gobernación de Antioquía. Estadísticas de morbilidad y mortalidad en Antioquia. [Internet]. Antioquia: Dirección seccional de salud, protección social, 2021. [En línea] Disponible en: [https://www.dssa.gov.co/images/asis/analisis_de_situacion_en_salud_antioquia_2021_Final_\(25-03-2021\)_3.pdf](https://www.dssa.gov.co/images/asis/analisis_de_situacion_en_salud_antioquia_2021_Final_(25-03-2021)_3.pdf)
 10. Camargo L, Taipe V. Percepción de los padres sobre calidad del cuidado de enfermería a pacientes pediátricos en Hospital San Juan de Lurigancho. Lima, 2017. [En línea] Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12970/129>
 11. Guinea M. Percepción de padres de niños menores de 5 años sobre atención humanizada de enfermera en servicio CRED en centro de salud Mirones. Lima, 2016. [En línea] Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12672/5371>
 12. Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud para el Control del Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño menor de cinco años. Lima: Ministerio de Salud; 2017. Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. [En línea] Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/190581-537-2017-minsa>
 13. INEI. Peru. Encuesta demográfica y de salud familiar. 2010. [En línea] Disponible en: <https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2010/endes00/index.html>

- 14.**Camino K, et al. Percepción del cuidado de enfermería y satisfacción del usuario en el Servicio de Emergencia-Observación del HRHDE-Arequipa 2017. [En línea] Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12727/7389>
- 15.**Forchuk C, Reynolds WJ. A phenomenological investigation of Peplau's concepts of nurse-patient interaction. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2001;8(4):357-365. [En línea] Disponible en: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0894318417693286>

ANEXOS

ANEXO A: VALIDACIÓN

VALIDACION Y CONFIABILIDAD DE LA ESCALA DE PERCEPCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS CRITERIOS	Nº de Jueces					p
	1	2	3	4	5	
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación.	1	1	1	1	1	0.000
2. El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio	1	1	1	1	1	0.000
3. La estructura del instrumento es adecuado.	1	1	1	1	1	0.000
4. Los ítems (preguntas) del instrumento están correctamente formuladas (clara y entendibles)	1	1	1	1	1	0.000
5. Los ítems del instrumento responden a la operacionalización de variables	1	1	1	1	1	0.000
6. La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento	1	1	1	1	1	0.000
7. Las categorías de cada pregunta (variables) son suficientes	1	1	1	1	1	0.000
8. El número de ítems (preguntas) es adecuado para su aplicación.	1	1	1	1	1	0.000

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable ()

Aplicable después de corregir ()

No aplicable ()

Se ha considerado lo siguiente:

1 (SI) = De acuerdo

0 (NO) = En desacuerdo

La tabla muestra la validación de los 5 expertos, respecto al instrumento, mediante la prueba binomial en base a 8 criterios, la cual determina que existe evidencia significativa para determinar la concordancia entre los jueces expertos ($p < 0.05$).

La concordancia favorable entre los 5 jueces expertos, indican que el instrumento es válido y aplicable.

ANEXO B: CONFIABILIDAD

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO ESCALA DE PERCEPCION SOBRE LA ATENCION DE ENFERMERIA EN EL PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.

El instrumento se confióbilizó mediante una prueba piloto aplicada a 30 madres de niños menores de 5 años, resultando el coeficiente de Cronbach: 0.89, es decir una muy fuerte confiabilidad.

N	ITEM																								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	104
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	118
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	120
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	120
5	5	4	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	5	5	5	5	5	4	4	5	109
6	5	4	5	5	4	3	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	5	5	5	5	5	4	4	5	109
7	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	115
8	5	4	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	4	4	5	3	5	5	5	5	5	4	4	5	109
9	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	120
10	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5	5	5	105
11	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	104
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	118
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	120
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	120
15	5	4	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	5	5	5	5	5	4	4	5	109
16	5	4	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	5	5	5	5	5	4	4	5	109
17	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	115
18	5	4	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	5	5	5	5	5	4	4	5	109
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	120
20	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5	5	5	105
21	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	104
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	118
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	120
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	109
25	5	4	5	5	4	3	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	5	5	5	5	5	4	4	5	109
26	5	4	5	5	5	4	3	5	5	5	5	5	4	4	4	3	5	5	5	5	5	4	4	5	115
27	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	109
28	5	4	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	4	4	5	120
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	105
30	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5	5	5	5	38,16
Varianza	0,17	0,26	0,17	0,17	0,25	0,71	0,17	0,09	0,09	0,22	0,00	0,22	0,25	0,26	0,26	0,71	0,17	0,87	0,00	0,00	0,09	0,25	0,22	0,00	
Suma var																									5,58

Puntajes del Coeficiente de Correlación de Cronbach

Coeficiente de Correlación

Magnitud

0,70 a 1,00	Muy fuerte
0,50 a 0,69	Sustancial
0,30 a 0,49	Moderada
0,10 a 0,29	Baja
0,01 a 0,09	Despreciable

ANEXO C: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

FICHA DE RECOLECCIÓN

Presentación:

El presente cuestionario busca obtener información sobre la percepción de la atención de enfermería en el programa de crecimiento y desarrollo en las madres de niños menores de 4 años del Centro de Salud Jesus María; por lo cual solicitamos su participación para el llenado del presente cuestionario que es anónimo y las respuestas solo serán de uso para fines del estudio. Le pedimos que la respuesta sea lo más veraz y sincera.

Datos Generales de la madre:

1. Edad: _____
2. Estado civil: Soltera () Conviviente () Casada ()
Separada ()
3. Grado de Instrucción: Sin Instrucción () Primaria ()
Secundaria () Superior ()
4. Ocupación: _____

Datos del niño:

5. Edad: _____
6. Sexo: Masculino () Femenino ()

PERCEPCIÓN DE LAS MADRES SOBRE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS EN EL SERVICIO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CENTRO DE SALUD "JESÚS MARÍA"

A continuación, se les presenta una serie de ítems, lea cuidadosamente cada uno, y marque con un aspa (X) en cualquiera de los 5 recuadros que usted considere conveniente.

1 = Totalmente desfavorable (TD)

2 = Desfavorable (D)

3 = Ni favorable ni desfavorable (NF)

4 = Favorable (F)

5 = Totalmente Favorable (TF)

	1	2	3	4	5
Dimensión humana					
1. Al ingresar al consultorio, la enfermera saluda.					
2. La enfermera llama al niño/a por su nombre					
3. Al terminar la consulta, la enfermera se despide.					
4. La enfermera trata con respeto y cortesía a su niño/a.					
5. La enfermera muestra interés en la consulta.					
6. La enfermera se preocupa por la privacidad en la atención del niño.					
7. La enfermera se preocupa por brindar confianza y seguridad al niño.					
8. La enfermera brinda orientaciones de manera clara y entendible.					
Dimensión técnico-científica					
9. La enfermera está atenta ante alguna molestia de su niño.					
10. La enfermera pregunta si entendió lo que le explicó.					
11. La enfermera responde a sus dudas.					
12. La enfermera le explica los procedimientos a realizar a su niño.					
13. La enfermera le explica cómo se encuentra su niño luego de la evaluación física.					

14. La enfermera le da indicaciones sobre el cuidado de su niño.					
15. La enfermera le brinda consejos sobre la alimentación de su niño.					
16. La enfermera le recomienda vitaminas para su niño.					
Dimensión entorno					
17. El consultorio donde trabaja la enfermera le brinda comodidad para la atención de su niño.					
18. En la sala de espera, hay suficientes lugares para sentarse.					
19. El consultorio donde trabaja la enfermera se encuentra limpio y ordenado.					
20. El consultorio donde trabaja la enfermera se encuentra ventilado.					
21. El consultorio donde trabaja la enfermera se encuentra iluminado.					
22. El ambiente del consultorio donde trabaja la enfermera está adaptado para la edad de su niño.					
23. El tiempo de espera para la consulta fue el adecuado.					
24. La duración de la consulta de la enfermera fue el adecuado.					

ANEXO D

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES

El objetivo de este documento es proporcionar una explicación detallada de la investigación titulada "Percepción de las Madres sobre la Atención de Enfermería a Niños Menores de 4 Años en el Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud 'Jesús María' ", así como su propósito y su proceso de desarrollo.

Propósito de la Investigación:

El propósito de este estudio es comprender la percepción materna sobre la atención de enfermería brindada a niños menores de 4 años en el Centro de Salud "Jesús María" durante el período mencionado. Esto se logrará a través de entrevistas en profundidad para explorar sus experiencias y perspectivas.

Proceso de Participación:

Si decide participar en este estudio, se le pedirá que participe en una entrevista a profundidad que tomará aproximadamente 10 minutos de su tiempo. Esta conversación será grabada para que el investigador o investigadora pueda transcribir con precisión sus comentarios.

Participación Voluntaria:

Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Cualquier información recopilada será tratada con la más estricta confidencialidad y solo se

utilizará para los propósitos de esta investigación. No se le pedirá ninguna forma de identificación personal.

Dudas y Retiro:

Si en algún momento tiene preguntas o se siente incómoda o incómodo con alguna pregunta, puede plantear sus inquietudes o abstenerse de responder sin ninguna consecuencia negativa. Puede retirarse del estudio en cualquier momento sin perjuicio alguno.

Agradecimiento:

Le agradecemos su participación en esta investigación, que contribuirá al avance del conocimiento en el campo de la enfermería y la atención infantil. Sus aportes son valiosos y podrían beneficiar a futuras generaciones de madres y niños.

Consentimiento:

Al firmar este documento, doy mi consentimiento para participar en el estudio y afirmo que he recibido información verbal sobre el mismo. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y discutir cualquier aspecto de la investigación. Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme en cualquier momento sin consecuencias negativas.

También entiendo que mis datos personales, incluyendo información relacionada con mi salud, podrán ser utilizados según lo descrito en la hoja de información proporcionada. Tendré derecho a recibir una copia de este formulario de

consentimiento e información del estudio y podré solicitar información sobre los resultados del estudio una vez que haya concluido.

Para obtener más información o aclaraciones, puedo comunicarme con KATERIN ESTEFANI BAO VILL, Investigadora a cargo.

Nombre completo del participante	Firma	Fecha
Nombre del Investigador	Firma	Fecha